Tórax: topografía y síntomas respiratorios

SEMIOLOGIA · Clase 15 · referencias del tórax, tos, esputo y hemoptisis

1 · REFERENCIAS PARA UBICAR UN HALLAZGO

Tórax
se ubica con líneas (esternal media, paraesternal, medioclavicular, axilares, escapular y media posterior), costillas y columna

se cuenta desde

7.ª vértebra cervical
apófisis espinosa más prominente de la base del cuello; desde ella se cuentan las dorsales hacia abajo

fija el nivel

Costillas y espacios
el espacio toma el número de la costilla de arriba; la 11.ª y la 12.ª son flotantes

se numeran por la costilla

fija el nivel

si la columna se desvía

F1 **Escoliosis**
desviación lateral de la columna, casi siempre compensadora; de espaldas la columna debe ir recta

junto a una cifosis

F1 **Cifoescoliosis**
la escoliosis con cifosis restringe la ventilación y a la larga lleva a cor pulmonale crónico

pesa sobre el pulmón

a la derecha marca el hígado

Matidez hepática
el hemitórax derecho suena claro hasta el 5.º espacio intercostal (borde superior del hígado)

fija el límite

en el pulmón derecho

F3 **Lóbulo medio** (pulmón derecho: 3 lóbulos)
solo segmentos lateral y medial 🛍️; el «medio basal» es del lóbulo inferior

ubica el lóbulo

sobre el diafragma, según el banco

F2 **Maniobra de Pallard** (banco)
mano en el epigastrio que empuja las vísceras hacia arriba para confirmar parálisis diafragmática; no está en la teoría

vigila el diafragma

Con las referencias fijadas, todo hallazgo se ubica y se nombra antes de interpretar el síntoma

el síntoma guía es la

2 · LA TOS: REFLEJO DE DEFENSA Y DE DÓNDE NACE

Tos
reflejo de defensa que expulsa lo que irrita la vía aérea

con esta secuencia

Secuencia del reflejo
inspiración profunda, cierre de la glotis y espiración forzada: sube la presión del tórax y del abdomen

lo activan cuatro

Cuatro estímulos
inflamatorio (edema, exudado), mecánico (cuerpo extraño), químico (gases, polvo) y térmico (aire muy frío o caliente)

pero también nace fuera del bronquio

F4 **Receptores fuera del bronquio**
la pleura y el esófago también disparan la tos: neumotórax, derrame, neumonía

como en el

F5 **Reflujo gastroesofágico**
causa de tos aguda (paso del ácido a la vía aérea)

salvo el

F4 **Excepción: infarto agudo de miocardio**
no irrita esos receptores y no produce tos

si arrastra material, es

Tos productiva
neumonía, bronconeumonía, absceso y bronquiectasias

orienta al

si no hay secreción, es

F5 **Tos seca** (sin esputo)
pleuritis, derrame pleural, IECA y tos psicógena; pericardio, diafragma y conducto auditivo 🛍️

según el tiempo

si dura poco, es aguda

Duración
aguda menos de 3 semanas; crónica más de 8 semanas

completa la

orienta al

si es sangre roja, es

Tos seca orienta a síndrome pleural; tos con expectoración, a síndrome bronquial

si se repite, hay

3 · TOS SOSTENIDA: COMPLICACIONES

Picos de presión repetidos
la espiración forzada contra la glotis cerrada transmite presión a pared, alvéolos y venas

pasa al pulmón

rompe la

F6 **Pared torácica**
fractura costal y hernia

sube la presión venosa

F6 **Pleuropulmonar**
neumomediastino y enfisema

F6 **Cardiovascular**
hipertensión pulmonar y epistaxis

se suma al daño de

baja el llenado del corazón

se suma al daño de

Sistema nervioso
síncope: menos llenado del corazón y menos sangre al cerebro

se suma al daño de

se suma al daño de

La tos sostenida daña pared, pulmón, vasos y cerebro; la «hemorragia pulmonar» del banco no está en la lista del docente

4 · QUÉ SALE: EL ESPUTO

lo que se expulsa es la

Expectoración
material de la vía aérea expulsado con la tos; el adulto sano produce ~100 ml de moco en 24 h y lo deglute

si es solo moco

F7 **Mucoso**
blanco, viscoso, escaso, como clara de huevo → asma, bronquitis aguda

si se suma pus

Purulento
amarillo-verdoso con pus → neumonía bacteriana o absceso; fétido si es por anaerobios

orienta la causa en el

si se suma inflamación

F8 **Mixto (mucopurulento)**
infección más inflamación → bronconeumonía

orienta la causa en el

según su color

Color
herrumbroso en neumonía; achocolatado en absceso amebiano

orienta la causa en el

según su cantidad

Volumen
500 a 600 ml/24 h en bronquiectasias, absceso y quiste hidatídico complicado

orienta la causa en el

si es trasudado alveolar

Seroso
rosado, espumoso y abundante: trasudado alveolar → edema agudo de pulmón

orienta la causa en el

El aspecto del esputo orienta la causa: moco solo, asma; moco y pus, bronconeumonía; pus franco, neumonía o absceso

5 · CUANDO SALE SANGRE: HEMOPTISIS

Hemoptisis
sangre roja, rutilante y espumosa por la glotis, tras la tos, de pH alcalino

según el volumen

Volumen en 24 h
pequeña menos de 30 ml; moderada 30-200 ml; masiva más de 600 ml

si pasa de 600 ml

Hemoptisis masiva
shock hipovolémico o asfixia por coágulos

se reconoce en el

su causa más frecuente

Causas
en nuestro medio, primero tuberculosis; luego bronquiectasias, bronquitis, embolia pulmonar, estenosis mitral y neoplasias

se reconoce en el

si coincide con la regla

F9 **Hemoptisis catamenial**
sangra con cada menstruación: endometriosis pulmonar 🛍️ (el «mitral» del banco es un error)

se reconoce en el

se separa de la

Hematemesis (no confundir)
tras náuseas y vómito, oscura en borra de café, pH ácido, con restos de alimento y seguida de melena

se reconoce en el

Sangre roja tras la tos y sin alimento es hemoptisis; si es cíclica con la regla, endometrio en el tórax

concepto · técnica · diagnóstico · signo · complicación · ejemplo · desenlace · síntoma · mecanismo · causa · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Sotomayor, apuntes de Semiología Médica 2020, tema 7 (07a Anamnesis respiratoria, 07b Topografía, 07c Percusión) — teoría del docente; lóbulos, Pallard y hemoptisis catamenial: 🛍️ literatura o banco